



Hématurie

Préparation au concours de Résidanat

Dr Ahmed LETAIEF

Service de Néphrologie

CHU Fattouma Bourguiba Monastir

Faculté de Médecine de Monastir

2024-2025

Objectifs éducationnels

- 1. Définir l'hématurie macroscopique et l'hématurie microscopique.**
- 2. Distinguer une hématurie d'une coloration anormale des urines d'une autre origine.**
- 3. Enumérer les éléments cliniques et biologiques permettant d'évaluer le retentissement d'une hématurie ainsi que le degré de sa gravité.**
- 4. Suspecter l'origine d'une hématurie selon son caractère initial, terminal ou total lors de la miction.**
- 5. Distinguer l'origine urologique d'une origine néphrologique d'une hématurie à partir des données cliniques et biologiques.**
- 6. Planifier les explorations radiologiques et endoscopiques en cas d'hématurie.**

Objectifs éducationnels

7. Expliquer l'intérêt de l'exploration du système complémentaire au cours des hématuries.
8. Enumérer les néphropathies glomérulaires pouvant être révélées par une hématurie.
9. Réunir les arguments anamnestiques, cliniques et para cliniques permettant de retenir le diagnostic d'une glomérulonéphrite aiguë chez l'enfant.
10. Poser l'indication d'une ponction biopsie rénale devant une hématurie.
11. Citer les principales causes d'hématurie d'origine rénale, vésicale et urétro-prostatique.
12. Planifier la conduite à tenir en urgence devant une hématurie macroscopique grave d'origine urologique.

QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES

L'hématurie se définit par :

- A. La présence d'urine rouge**
- B. Nombre d'hématies dans les urines $> 10/\text{mm}^3$**
- C. Nombre d'hématies dans les urines $> 1000/\text{ml}$**
- D. Examen aux bandelettes urinaires positif**
- E. La présence de l'hème dans les urines**

Concernant les hématuries, quelle(s) affirmation(s) est (sont) exacte(s) ?

- A - Les bandelettes réactives ne détectent que les hématuries glomérulaires**
- B - Une hématurie glomérulaire est caractérisée par des hématies déformées**
- C - Les hématuries microscopiques ne nécessitent que rarement une imagerie**
- D - La présence de caillots oriente vers une étiologie urologique**
- E - Les hématuries glomérulaires sont toujours microscopiques**

Un homme de 20 ans sans antécédents médicaux présente une hématurie microscopique asymptomatique isolée lors d'un examen physique de routine. Il ne prend aucun médicament et ne consomme pas de drogues illicites. Laquelle des observations suivantes suggère une hématurie glomérulaire ?

- A. Présence de nombreux globules rouges isomorphes dans le sédiments urinaire**
- B. Présence de nombreux globules rouges et globules blancs isomorphes dans le sédiment urinaire**
- C. Présence de nombreux globules rouges ou acanthocytes dysmorphiques dans le sédiment urinaire**
- D. Présence de cylindres leucocytaires**
- E. Présence d'une protéinurie à 0,2 g/24 heures**

Quelle(s) affirmation(s) est (sont) vraie(s) ?

- A - Une hématurie macroscopique oriente vers une étiologie plus grave qu'une hématurie microscopique**
- B - Une hématurie microscopique isolée oriente le plus souvent vers une étiologie néphrologique**
- C - Une hématurie microscopique dépistée à la bandelette urinaire nécessite une confirmation par un examen cytologique urinaire**
- D - Une hématurie macroscopique terminale oriente vers une origine rénale du saignement**
- E - Une origine vésicale ne peut pas être envisagée en cas d'hématurie totale**

Devant une hématurie microscopique et une douleur lombaire unilatérale on évoque:

- A. Une lithiase urinaire
- B. Une polykystose rénale
- C. Un infarctus rénal
- D. Une GNA post infectieuse
- E. Une tumeur rénale

Devant une hématurie macroscopique récidivante chez un homme jeune on évoque :

- A. Une GNA post infectieuse**
- B. Une néphropathie à IgA**
- C. Une amylose rénale**
- D. Un syndrome d'Alport**
- E. Une lésion glomérulaire minime**

Les médicaments suivants peuvent causer une hématurie vraie:

- A. Allopurinol**
- B. Métronidazole**
- C. Rifampicine**
- D. Cyclophosphamide**
- E. Phénacétine**

L'association d'une hématurie totale avec 2 gros reins chez un homme âgé de 65 ans ayant des antécédents familiaux d'insuffisance rénale chronique fait évoquer :

- A- Une polykystose rénale**
- B- Un syndrome d'Alport**
- C- Une tuberculose rénale**
- D- Une néphropathie à IgA**
- E- Une lithiase rénale**

Une hématurie macroscopique peut révéler :

- A- Une glomérulonéphrite membrano-proliférative**
- B- Une lésion glomérulaire minime**
- C- Une glomérulonéphrite aigue post streptococcique**
- D- Une néphropathie à IgA**
- E- Une lithiase urinaire**

Une femme de 35 ans présente une hématurie microscopique avec un rapport albuminurie à 2500 mg/24h avec un complément sérique bas. Quels sont les diagnostics possibles chez cette patiente ?

- A. Néphropathie avec dépôts mésangiaux d'IgA**
- B. Néphropathie lupique**
- C. Purpura rhumatoïde**
- D. Polykystose rénale**
- E. Polyangéite avec granulomatose**

Chez un homme âgé de 68 ans et tabagique, la présence d'une hématurie de 500 hématies/mm³ fait évoquer en premier :

- A. Un lupus érythémateux systémique
- B. Une amylose rénale
- C. Une tumeur vésicale maligne
- D. Un myélome
- E. Une tubulopathie toxique

Une hématurie totale :

- A- peut être d'origine vésicale**
- B- peut compliquer un calcul rénal**
- C- peut provenir du haut appareil urinaire**
- D- est le plus souvent un signe de gravité**
- E- peut être d'origine néphrologique**

La présence de cylindres hématiques:

- A- est la règle en cas d'hématuries abondantes**
- B- témoigne d'une hématurie d'origine glomérulaire**
- C- peut s'observer en cas de syndrome néphrotique pur**
- D- peut s'observer dans la glomérulonéphrite à dépôts mésangiaux d'IgA**
- E- peut s'observer en cas d'hémolyse intravasculaire**

En faveur d'une hématurie d'origine néphrologique, on peut retenir :

- A. La présence de caillots sanguins.**
- B. La présence de cylindres hématiques.**
- C. La présence d'une protéinurie > 3g/24h.**
- D. Le caractère terminal de l'hématurie.**
- E. Le caractère initial de l'hématurie.**

Un patient de 30 ans présente une protéinurie à 2g/24h et une hématurie microscopique. La P.A. est à 130/80 mmHg, le DFG=100 ml/mn. Il n'y a pas d'anomalies rénales ou urinaires à l'uroscanner. Quelle investigation réaliser ?

A- Echographie rénale

B- Scintigraphie rénale

C- Biopsie rénale

D- Urétéro-pyélographie rétrograde

E- Endoscopie vésicale

Concernant les hématuries, quelle(s) affirmation(s) est(sont) exacte(s) ?

- A. Les bandelettes réactives détectent plus de 5 hématies par mm³**
- B. Une hématurie glomérulaire est caractérisée par des hématies déformées**
- C. Les cylindres caractérisent les hématuries glomérulaires**
- D. Les hématuries d'effort sont exclusivement glomérulaires**
- E. Les hématuries d'effort disparaissent après 48 heures de repos**

En cas d'hématurie positive à ++ à la BU et négative à l'ECBU on évoque :

- A- Une hématurie terminale**
- B- Une myoglobulinurie**
- C- Une hémoglobinurie**
- D- Une néoplasie vésicale**
- E- Une ingestion de betteraves**

Une ponction biopsie rénale est indiquée devant une hématurie si elle s'associe à:

- A. Une protéinurie**
- B. Une leucocyturie**
- C. Une insuffisance rénale**
- D. Des caillots sanguins**
- E. Une hypotension artérielle**

Les glomérulonéphrites qui peuvent être révélées par une hématurie sont :

- A. L'amylose rénale**
- B. La néphropathie diabétique**
- C. La GN membranoproliférative**
- D. Le syndrome de Good Pasture**
- E. Le syndrome d'Alport**

Devant une hématurie associée à une hypocomplémentémie on évoque:

- A. Une glomérulonéphrite à dépôts mésangiaux d'IgA**
- B. Une néphropathie lupique**
- C. Une glomérulonéphrite membranoproliférative**
- D. Une vascularite à ANCA**
- E. Un syndrome d'Alport**

Une hématurie associée à une hypocomplémentémie s'observe au cours de :

- A. Une cryoglobulinémie**
- B. Une endocardite infectieuse**
- C. Un Syndrome de Good Pasture**
- D. Une maladie des emboles de cholestérol**
- E. Un syndrome hémolytique et urémique atypique**

Une hématurie associée à une baisse isolée de la fraction C3 du complément sérique avec une fraction C4 normale s'observe au cours de :

- A. GNA post infectieuse**
- B. Lupus érythémateux systémique**
- C. Cryoglobulinémie**
- D. Maladie des embolies de cholestérol**
- E. Syndrome hémolytique et urémique atypique**

La GNA post infectieuse peut être révélée par :

- A. Des crise convulsives**
- B. Un Œdème aigu du poumon**
- C. Une hématurie microscopique**
- D. Une leucocyturie aseptique**
- E. Une hypertension artérielle sévère**

Une GNA post infectieuse classique se caractérise par:

- A. Sa survenue de façon concomitante à une infection ORL**
- B. La présence d'un syndrome néphritique aigu**
- C. La présence d'un purpura au niveau des membres inférieurs associé**
- D. Un taux bas de la fraction C3 du complément sérique**
- E. Ses rechutes fréquentes**

Au cours de la GNA post infectieuse :

- A. Le recours à la PBR est systématique chez les enfants pour confirmer le diagnostic**
- B. Le complément sérique reste bas pendant 06 mois**
- C. Le syndrome néphrotique est fréquent**
- D. L'insuffisance rénale est modérée**
- E. Les anticorps anti cytoplasme des polynucléaires neutrophile (ANCA) sont souvent positifs**

Au cours de la GNA post infectieuse bénigne:

- A. Les signes cliniques apparaissent de façon concomitante avec l'infection ORL**
- B. L'hématurie est toujours macroscopique**
- C. Le traitement étiologique se base la corticothérapie**
- D. L'évolution est le plus souvent favorable**
- E. Le germe le plus incriminé est le streptocoque epidermidis**

Concernant la glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse

- A. Elle est le plus souvent liée à un streptocoque beta hémolytique du groupe A**
- B. Elle affecte plus volontiers les sujets âgés**
- C. Elle s'accompagne d'une protéinurie le plus souvent sélective**
- D. A l'histologie : il y a une prolifération endocapillaire diffuse**
- E. Elle s'accompagne de signes cliniques d'hyperhydratation**

Les examens complémentaires à demander devant une hématurie microscopique avec une protéinurie à 2g/24h chez une femme âgée de 25 ans sont:

- A. Artériographie**
- B. Recherche des anticorps anti nucléaire**
- C. Complément sérique**
- D. Biopsie rénale**
- E. Cystoscopie**

CAS CLINIQUES

CAS CLINIQUE N°2

- Un homme de 27 ans vous est adressé pour anomalie urinaire. Il est comptable, célibataire et rapporte un tabagisme à 10 paquets-année.
- Depuis deux ans, au cours d'un examen systématique en médecine du travail, une protéinurie et une hématurie ont été mises en évidence à la bandelette urinaire. Un bilan a été réalisé en ville et montre :
- **Sang** : créatinine 60 $\mu\text{mol/l}$, Na 138 mmol/l, K 3,8 mmol/l ;
- **Urine**: protéine 1,2 g/24heures, ECBU : hématies 60/mm³, leucocytes 1/mm³, culture stérile.

Question N°1

- **Quels éléments anamnestiques recherchez-vous ?**

Question N°2

- Aucune autre donnée pertinente n'est recueillie à l'interrogatoire.
- La pression artérielle est à 150/90mmHg, le pouls à 65 (debout et couché). Le reste de l'examen est sans particularité.
- Quels examens complémentaires de première intention demandez-vous et dans quels délais ?

Question N°3

- **Quels éléments para cliniques vous orienteraient vers une pathologie glomérulaire ?**

Question N°4

- Les taux des fractions C3 et C4 du complément sérique sont normaux.
- Quels Dg évoquez-vous devant ce syndrome glomérulaire fait de protéinurie + hématurie avec fonction rénale normale et complément sérique normal ?

Question N°5

- Une ponction biopsie rénale vous paraît-elle indiquée ?
- Justifier votre réponse en mettant en balance les risques d'un tel examen et ce que vous pouvez en attendre dans cette situation ?

CAS CLINIQUE N°3

- **Patiente âgée de 20 ans ayant des antécédents familiaux de maladie rénale chronique (frère et sœur) se plaint de céphalées et d'oligurie.**
- **Examen : Température :37°, PA : 190/100mmHg, OMI discrets, BU: H:++, Pr: ++**
- **Biologie: Créatinine sérique: 600μmol/l, Hb: 6g/dl, GB: 4500/mm³, plaquettes: 60000/mm³, CRP: 20mg/l, protéinurie: 1,5g/24h, ECBU: H: 200/mm³, L: 4/mm³, culture: négative.**

Les causes possibles de l'hématurie chez cette patiente :

- A. Lupus érythémateux systémique**
- B. Endocardite infectieuse**
- C. GNA post infectieuse**
- D. Syndrome hémolytique et urémique atypique**
- E. Vascularite à ANCA**

Les examens utiles à demander à ce stade sont :

- A. Test de Coombs direct**
- B. Dosage des fractions du complément sérique**
- C. Une ponction biopsie rénale**
- D. Haptoglobine**
- E. Recherche des anticorps antinucléaires**

Haptoglobine effondrée, taux de C3 bas, AAN négatif, test de Coombs direct négatif, le dg le plus probable est :

- A. Lupus érythémateux systémique**
- B. Endocardite infectieuse**
- C. GNA post infectieuse**
- D. Syndrome hémolytique et urémique atypique**
- E. Vascularite à ANCA**

CAS CLINIQUE N°4

- Un jeune homme de 25 ans présente une hématurie macroscopique , ayant duré quatre jours puis disparue spontanément.
- L'anamnèse note une sinusite survenue deux jours avant l'apparition de l'hématurie totale non douloureuse.
- Examen physique : PA à 180/95 mm Hg, BU: protéinurie : ++ et hématurie : +++.
- Examen du sédiment urinaire : présence de cylindres hématiques et des globules rouges déformés.
- Biologie : la créatininémie est à 150 $\mu\text{mol/l}$, complément sérique normal.

En faveur de l'origine glomérulaire de l'hématurie chez ce patient on relève :

- A. Le caractère total de l'hématurie**
- B. Le caractère indolore de l'hématurie**
- C. L'âge jeune**
- D. Présence de GR déformés au sédiment urinaire**
- E. Présence d'une insuffisance rénale**

Les diagnostics possibles sont :

- A. Une GNA post infectieuse**
- B. Une Néphropathie à IgA**
- C. Une polyangéite avec granulomatose**
- D. Une lésion glomérulaire minime**
- E. Une néphropathie lupique**

Les examens complémentaires utiles au diagnostic étiologique sont :

- A. Recherche des ANCA**
- B. Cystoscopie**
- C. Ponction biopsie rénale**
- D. Dosage des ASLO**
- E. Uroscanner**

